내과 외래 발진 접근
피부에서 전신질환으로

형태·분포·약물력과 동반 증상으로 진단의 방향을 잡는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

피부 소견이 내과 진단의 단서가 되는 세 가지 이유

특이 병변·초기 징후·응급 신호를 함께 읽는다

특이적인 병변

Gottron 구진은 피부근염, Janeway 병변은 감염성 심내막염의 진단 단서다. 피부 병변의 정확한 이름과 위치를 먼저 기록한다.

전신 증상보다 먼저

나비모양 발진, 황색종, 흑색극세포증은 각각 자가면역·지질·대사질환의 초기 신호일 수 있다. 피부와 내부 장기를 연결한다.

즉각적인 행동

SJS/TEN, 아나필락시스, 감염성 심내막염은 피부에서 응급 상황을 알아차릴 수 있다. 발진을 분류하면서 의뢰 시점을 함께 판단한다.

임상 연결 · 특이 병변·초기 징후·응급 신호를 함께 읽는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

원발진: 색조 변화와 만져지는 병변을 구분한다

크기 기준과 병변의 높이·내용물·깊이를 연결한다

반점·반

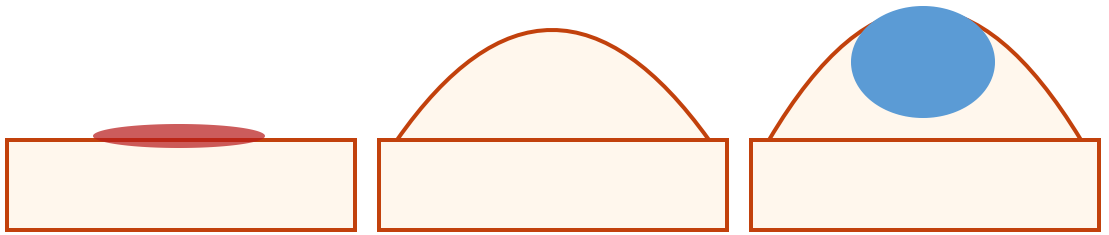
융기·함몰 없이 색조만 변화한다. 반점(macule)은 <1 cm, 반(patch)은 >1 cm이다.

구진·판·결절

구진(papule)은 <1 cm, 판(plaque)은 >1 cm의 융기 병변이다. 결절(nodule)은 ≥1 cm로 만져지는 둥근 병변이다.

소수포·수포·농포

소수포는 <1 cm, 수포는 >1 cm의 액체 포함 병변이며 농이 있으면 농포(pustule)다.



색조만 변화 | 융기·촉진 | 액체·농 포함

설명 도식 · 크기 기준과 병변의 높이·내용물·깊이를 연결한다

임상 연결 · 크기 기준과 병변의 높이·내용물·깊이를 연결한다

팽진·까짐·궤양·속발진을 구분한다

깊이와 시간에 따른 변화를 함께 기록한다

원발 병변의 성상

팽진 (wheal)

표재 진피의 혈관 반응에 의한 일시적인 부종성 융기다. 가려움을 동반한 두드러기의 전형적인 소견이다.

까짐 (erosion)

표피만 소실되며 흉터를 남기지 않는다.

궤양 (ulcer)

진피까지 소실되어 흉터를 남긴다.

변형된 병변과 진찰

속발진

원발진이 진행하거나 변형되면서 인설, 딱지, 태선화, 위축, 열창이 나타난다.

시간의 단서

지속성인지 일시성인지, 경과와 재발 여부를 확인한다.

전신 관찰

좋은 조명에서 두피·귀·털·손발톱과 구강·성기 점막까지 살핀다.

임상 연결 · 깊이와 시간에 따른 변화를 함께 기록한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

병력: 처방약만 묻고 끝내지 않는다

발생 시점과 최근 4~8주 이내 약물력을 연결한다

1 발병일·기간

지속/일시성, 변화 속도, 이전 발진과 재발 여부

2 발생 부위

피부 외 동반 증상과 전신 증상의 순서

3 모든 약물

처방약·한방약·민간요법·건강보조식품

4 국소 사용제

피부·점막 외용제까지 약물력에 포함

5 노출과 환경

여행·직장·가정환경·계절·기온·습도·기후

6 관련 병력

성생활, 가족의 피부·알레르기·유전질환

임상 연결 · 발생 시점과 최근 4~8주 이내 약물력을 연결한다

진찰: 분포·배열·촉진이 감별의 방향을 정한다

전신 시진과 점막 평가를 피부 진찰에 포함한다

분포와 배열

대칭인지 편측인지, 일광 노출부인지, 군집성인지 확인한다. 환자가 편안함을 느낄 수 있는 환경에서 전신을 관찰한다.

촉진

유동성·견고함·온도·습도·긴장도를 확인한다. 보이는 색조만으로 병변을 분류하지 않는다.

특이 징후

Nikolsky 징후와 표피 박리는 중증 피부점막반응을 시사한다. 구강·안구·생식기 점막도 함께 확인한다.

임상 연결 · 전신 시진과 점막 평가를 피부 진찰에 포함한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

수두: 한 부위에 여러 단계의 발진이 공존한다

VZV 초감염 — 얼굴·두피에서 몸통·팔다리로 확산

발진의 진행

구진이 12시간 이내 수포로 진행하고 배꼽모양 함몰을 보인다. 농포와 가피가 함께 관찰될 수 있다.

시간과 전염성

약 2주의 잠복기. 성인은 발열·두통·요통이 2~3일 선행한다. 발진 1~2일 전부터 모든 병변이 가피가 될 때까지 전염성이 있다.

성인 합병증

수두폐렴, 이차 세균감염, 뇌염을 살핀다. 강의에서 제시한 수두폐렴 사망률은 10~30%다.



진단과 평가의 연결 **임상 소견을 연결한 도식**

설명 도식 · VZV 초감염 — 얼굴·두피에서 몸통·팔다리로 확산

임상 연결 · VZV 초감염 — 얼굴·두피에서 몸통·팔다리로 확산

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

수두 치료와 대상포진의 경과를 구분한다

치료의 시작 시점과 중증·면역저하 조건을 보존한다

성인 수두

Acyclovir 800 mg 경구 1일 4회, 7일. 발진 24시간 이내 시작을 권고한다.

중증·면역저하 수두

수두폐렴 등 중증이거나 면역저하 상태이면 acyclovir 10 mg/kg IV q8h가 필요하다.

대상포진 경과

발진 4~5일 전 피부절 통증·압통·감각이상이 선행한다. 12~24시간 내 수포, 3일째 농포, 7~10일 가피, 평균 약 3주 경과다.

임상 연결 · 치료의 시작 시점과 중증·면역저하 조건을 보존한다

대상포진: 편측 피부절 분포와 합병증을 살핀다

VZV 재활성화 — 고령과 세포면역 저하가 중요한 배경이다

전형적 분포

중앙선을 넘지 않는 편측 띠 모양 홍반·군집 수포. 수두보다 느리게 진행한다.

전구 통증

발진 4~5일 전 시작. 60세 이상에서 흔하고 30세 이하에서는 드물다.

호발 부위

흉부 55%, 뇌신경 20%, 요추신경 15%, 천골신경 5%가 강의·교재에 제시되었다.

포진후신경통

60세 이상에서 약 50%. 통증 지속을 염두에 두고 평가한다.

범발·신경계 합병증

수포 ≥25개인 범발성 대상포진, Ramsay-Hunt 증후군, 신경원성 방광을 살핀다.

안구 침범

코끝 수포인 Hutchinson 징후는 즉시 항바이러스 치료와 안과 의뢰 신호다. 항바이러스제는 발진 72시간 이내 시작한다.

임상 연결 · VZV 재활성화 — 고령과 세포면역 저하가 중요한 배경이다

매독: 원인불명 전신 발진과 손발바닥 침범

조기·만기 매독은 1년을 기준으로 구분한다

단계	시점	피부 소견과 임상 연결
1기	감염 후 2~3주	보통 1개의 무통성 경성하감. 3~8주 후 자연 소실, 서혜부 림프절 종대.
2기	감염 후 4~10주	80% 이상 피부발진. 비소양성·다형성, 손발바닥 침범, 편평콘딜로마·점막 미란·좀먹은 탈모.
잠복기	조기 / 만기	피부 소견 없이 혈청검사 양성. 임상 증상이 없다.
3기	수년~수십 년 후	고무종(gumma), 신경·심혈관 매독. 원인불명 전신 발진과 손발 침범 시 RPR/VDRL을 고려한다.

임상 연결 · 조기·만기 매독은 1년을 기준으로 구분한다

루푸스: 피부 아형으로 전신 활동성을 읽는다

급성형·아급성형·만성형의 특징을 분리한다

급성 피부홍반루푸스 (ACLE)

전신형 급성 악화기에 흔하다. 콧등·양 볼의 대칭 나비모양 홍반은 비구순주름을 침범하지 않으며 자외선에 유발·악화된다.

아급성형 (SCLE)

항 Ro/SS-A 항체가 흔하다. 과각화성 구진비늘 또는 고리모양·다륜 판이 일광 노출부에 호발하며 흉터 없이 치유된다. 약 50%가 전신형 기준을 충족한다.

만성형 (CCLE)

원반모양 홍반루푸스(DLE)가 대표적이다. 경계 분명한 홍반 판, 비늘·모낭마개, 중심부 위축·흉터성 탈모. 전신형이 없거나 경미할 때 흔하다.

임상 연결 · 급성형·아급성형·만성형의 특징을 분리한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

피부근염: Gottron 구진과 연자색 발진을 찾는다

피부 위치와 내과적 동반 위험을 연결한다

특징적 소견

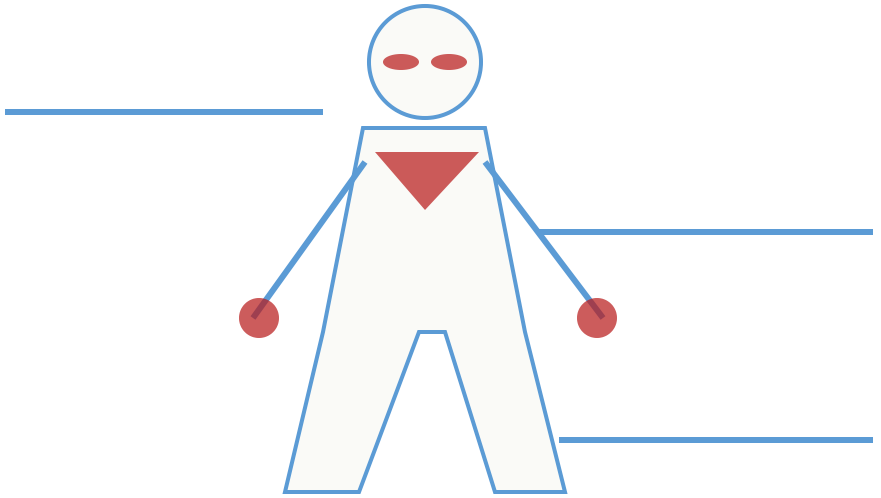
손가락 관절 위 각질 동반 보라색 구진이 Gottron 구진이다. 윗눈꺼풀의 부종과 보라색 변화가 heliotrope rash다.

분포

Gottron 징후는 손관절·팔꿈치·무릎·발목 폄측. 앞가슴 V sign, 뒷목·등 shawl sign, 허벅지 측면 holster sign을 확인한다.

동반 질환

기계공의 손은 간질폐질환과 연관된다. 손톱주위 모세혈관확장·다형피부증도 관찰한다.



설명 도식 · 피부 위치와 내과적 동반 위험을 연결한다

임상 연결 · 피부 위치와 내과적 동반 위험을 연결한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

피부근염의 암 위험·루푸스의 비특이 피부 징후

피부 병변을 확인한 다음 전신 평가로 이어간다

10~20%

악성종양 동반

성인 피부근염 환자에서 강의가 제시한 동반 위험

1~2년

주요 시기

피부근염 발병 1~2년 내 악성종양이 동반되는 경우가 많다.

4~6배

일반인 대비 위험

나이에 맞는 악성종양 선별검사를 시행한다.

피부근염에서 제시한 암

유방·폐·난소·전립샘·대장·비인두암.

루푸스의 비특이 소견

혈관염성 자색반·망상청피반·탈모·레이노현상·손톱주위 모세혈관확장은 질병 활동성의 지표가 된다.

임상 연결 · 피부 병변을 확인한 다음 전신 평가로 이어간다

IgA 혈관염: 피부·관절·장·콩팥의 네 징후

소아 75%, 성인 25% — 성인 평균 50세, 남성에 더 흔하다

촉진 가능한 자반

팔다리 폄측에 대칭적으로 나타나며 1일 내 출혈 병변으로 변한다. 5일 이내 소실되기 시작한다.

관절통·관절염 약 60%

관절주위 부종을 동반할 수 있다. 피부 소견과 관절 증상을 함께 확인한다.

복통·위장관 침범 약 60%

심하면 급성복증으로 오인될 수 있다. 피부 발진과 복부 증상의 연결이 중요하다.

콩팥 침범 약 40%

혈뇨가 나타나며 성인에서 콩팥 예후가 더 나쁠 수 있다. 선행 상기도·사슬알균 인두염, 성인 악성종양 연관과 IgA 침착을 함께 기억한다.

임상 연결 · 소아 75%, 성인 25% — 성인 평균 50세, 남성에 더 흔하다

약물반응: 지연성 장기 침범과 급성 표피 박리

의심 약물 즉시 중단과 신속한 의뢰가 핵심이다

DRESS / 약물 과민증후군

2~8주 후

발열·발진·내부장기 침범. 간 침범이 가장 흔하다.

검사·경과

림프절병증, 호산구증가/이상림프구. 중단 후에도 악화 가능하며 혈액·간기능·크레아티닌을 검사한다.

약물력

항경련제·sulfonamide·dapsone·allopurinol 등 모든 노출을 확인한다.

SJS / TEN

4~30일 후

약물·감염 관련 급성 피부점막반응. 여성에 약 2배 흔하다.

박리·점막

SJS <10%, overlap 10~30%, TEN >30%의 표피 박리. 약 90% 점막 침범과 Nikolsky 양성.

의뢰

원인약제 즉시 중단. 중증이면 화상센터 수준 집중치료, 안과 합병증 20~70%로 협진이 필수다.

임상 연결 · 의심 약물 즉시 중단과 신속한 의뢰가 핵심이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

아나필락시스: 피부와 호흡·순환 증상을 연결한다

대개 약물 투여 30분 이내 — epinephrine IM이 일차 치료다

피부·전신 증상

전신 두드러기·맥관부종에 기관지경련·호흡곤란, 혈압강하·빈맥, 복통·오심·구토·설사, 의식소실이 동반될 수 있다.

원인·기전

면역·비면역 기전 모두 가능하다. 페니실린이 가장 많이 보고되며 혈관조영제·혈장제·아스피린 등도 원인이다.

응급 조치

강의는 대개 30분 내 발생, 24시간 내 소실을 설명했다. 응급 처치가 늦으면 생명을 위협하며 epinephrine 근육주사를 일차 치료로 한다.

임상 연결 · 대개 약물 투여 30분 이내 — epinephrine IM이 일차 치료다

황색종: 형태가 시사하는 지질단백 이상

조직구가 지질을 포식한 황색~오렌지색 판 또는 결절

형태	위치	임상 연결
결절황색종	무릎·팔꿈치·엉덩이 신측	황색 구진이 단단한 결절로 융합. 베타지질단백이상혈증(3형).
건황색종	아킬레스건·손발 신전건	단단한 결절. 피부색은 정상일 수 있어 초기 진단이 어렵다. LDL 관련 2형.
발진황색종	사지 신측·엉덩이	<5 mm 황색 구진이 군집. 급성기 가려움. 고중성지방혈증 >1,000 mg/dL.
편평·안검황색종	눈꺼풀	가장 흔한 형태. 과반수는 지질 수치 정상. 가족고콜레스테롤혈증에서는 LDL 증가와 연관.

임상 연결 · 조직구가 지질을 포식한 황색~오렌지색 판 또는 결절

감염성 심내막염: 아픈 결절과 안 아픈 반점을 구분한다

원인불명 발열과 말초 피부 소견이면 혈액배양·심초음파

Osler 결절

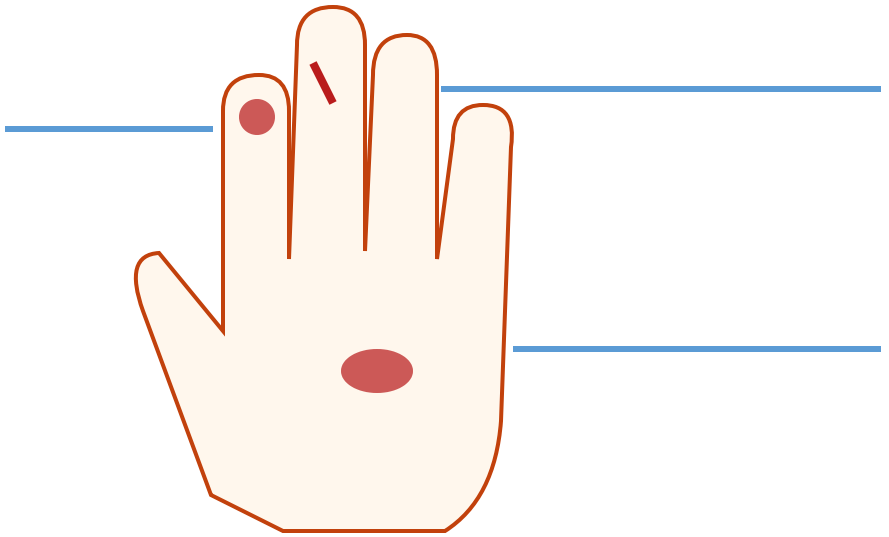
손끝의 통증성 적색 구진·결절, 창백한 중심. 수일~수주 지속하며 면역복합체 관련으로 설명했다.

Janeway 병변

손바닥·발바닥의 무통성 홍반성 반점이다. 패혈성 색전과 연관된다.

다른 소견

손톱 아래 splinter hemorrhage, 구강·결막·연구개·사지의 점출혈·자반. 원인균의 80%는 포도알균·사슬알균·장알균이며 S. aureus가 최다다.



설명 도식 · 원인불명 발열과 말초 피부 소견이면 혈액배양·심초음파

임상 연결 · 원인불명 발열과 말초 피부 소견이면 혈액배양·심초음파

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

당뇨병 피부 징후: 대사·혈관·신경·면역의 단서

혈당 조절 정도와 피부 병변의 경과가 항상 일치하지는 않는다

흑색극세포증

목·겨드랑이 회갈색 색소침착과 벨벳 비후. 비만·인슐린저항성 표지이며 악성종양도 감별한다.

당뇨피부병증

정강이 암적색 구진이 갈색 위축 흉터로 남는다. 당뇨병 환자의 약 30~40%에서 관찰된다.

당뇨지방생괴사

앞정강이 황갈색 위축성 판, 표면 혈관확장. 혈당 조절과 무관하며 드물게 궤양·편평상피세포암이 생긴다.

당뇨병발궤양

난치성이고 발 절단의 원인이 된다. 즉시 평가와 예방으로 연결한다.

피부 비후·관절 경직

피부경화증모양증후군의 prayer sign. 당뇨경화부종은 등 상부·목의 무통성 비함요부종으로 서서히 진행하고 잘 소실되지 않는다.

기타 소견

발진황색종은 고중성지방혈증과 연관. 당뇨병수포증은 염증·외상 없이 발등·정강이에 생기며 2~5주 후 흉터 없이 소실된다.

임상 연결 · 혈당 조절 정도와 피부 병변의 경과가 항상 일치하지는 않는다

갑상선: 따뜻하고 습한 피부 vs 차고 건조한 피부

피부·모발·손발톱과 점액부종의 양상을 대조한다

기능항진증 (hyperthyroidism)

피부

따뜻하고 습하며 매끄럽다. 얼굴 홍조·손바닥 홍반, 다한증·과색소침착.

모발·손발톱

가늘고 부드러운 모발, 광범위 비반흔성 탈모. Plummer 조갑은 손발톱 끝이 구부러진다.

Graves 피부병증

안구돌출, 앞정강이점액부종, 갑상선말단비대증(손가락곤봉형성). 전경골 병변은 오렌지껍질 같은 표면을 보인다.

기능저하증 (hypothyroidism)

점액부종

안면·안와주위 비함요부종, 코·입술 비대와 피부 비후.

피부

차고 창백하며 건조하다. 땀·피지 분비 감소, 손발바닥 각질과 카로틴 축적에 의한 황색 착색.

모발·손발톱

눈썹 바깥 1/3 소실, 건조하고 가는 모발·두피 탈모. 손발톱은 잘 부스러지고 종능선을 보인다.

임상 연결 · 피부·모발·손발톱과 점액부종의 양상을 대조한다

응급 의뢰: 피부 소견과 동반 증상을 묶어 판단한다

형태학적 분류와 동시에 즉시 행동이 필요한 신호를 찾는다

1. **발열·광범위 발진 + 약물력**
   DRESS 또는 SJS/TEN을 의심하고 즉시 의뢰
2. **표피 박리·Nikolsky 양성**
   SJS/TEN의 중요한 단서
3. **구강·안구·생식기 점막 침범**
   SJS/TEN에서 약 90% 동반
4. **두드러기·맥관부종 + 저혈압/기관지경련**
   아나필락시스 응급 처치
5. **발열 + Osler/Janeway/splinter**
   심내막염 의심: 혈액배양·심초음파
6. **코끝 수포·Hutchinson 징후**
   즉시 항바이러스 치료와 안과 의뢰

임상 연결 · 형태학적 분류와 동시에 즉시 행동이 필요한 신호를 찾는다

연자 Q&A: 둔부 수포·양측성·무통성 대상포진

정준민 연자의 Q&A 답변 — 분포·재발·경과를 함께 본다

둔부 반복 수포

동일·인접 부위에 군집 수포가 재발하면 단순포진을 우선 고려. 모낭 중심 농포는 모낭염, 깊은 통증 결절·배농·흉터는 화농성 한선염 감별.

회복과 치료 기간

재발 단순포진은 약제·용량에 따라 3~5일, 초발 생식기·항문주위는 통상 7~10일 치료. 대상포진 피부 회복은 대개 2~4주여서 5일 후 병변 잔존만으로 실패는 아니다.

양측·무통성

드물게 양측성도 가능하며 비전형 분포에서는 다른 질환·면역저하를 평가한다. 통증이 없어도 피부절 군집 수포면 의심하되 단순포진·접촉피부염을 감별한다.

임상 연결 · 정준민 연자의 Q&A 답변 — 분포·재발·경과를 함께 본다

연자 Q&A: 동전모양 발진과 눈 주변 대상포진

정준민 연자의 Q&A 답변 — 외래에서 이어지는 판단

동전모양 양측 발진

가려움·건조·홍반·각질·진물은 화폐상습진을 우선 고려. 변연 각질과 중심부 소실은 백선, 경계 분명한 두꺼운 각질판·팔꿈치·무릎·두피 침범은 건선 감별.

약제·진단 기록

수두는 acyclovir의 직접 근거가 더 확립되어 대표 약제로 소개했다. 대상포진은 전형 소견을 직접 확인했다면 위치·좌우·피부절·증상·경과를 기록해 임상 진단을 뒷받침한다.

안과·통증 의뢰

V1 영역은 안증상 없어도 조기 안과 의뢰. 시력저하·안구통은 당일 평가, 항바이러스제 시작은 지연하지 않는다. 심한 통증·치료 불충분·약물 사용 곤란은 조기 통증 의뢰한다.

임상 연결 · 정준민 연자의 Q&A 답변 — 외래에서 이어지는 판단

연자 Q&A: 동전모양 발진의 추가 감별

정준민 연자의 Q&A 답변 — 형태만으로 진단하지 않는다

습진·백선·건선

가려움·건조, 병변 전체의 홍반·각질·진물·딱지는 화폐상습진을 우선 고려한다. 변연부 각질과 중심부 소실·바깥 확장은 백선, 두꺼운 각질판과 팔꿈치·무릎·두피 침범은 건선 감별이다.

일광·치료 반응

일광 노출부 고리모양 발진이 대칭적이고 햇빛에 악화되면 SCLE도 감별한다. 비전형적이거나 치료에 반응하지 않으면 피부과로 연결한다. 백선에 스테로이드 연고만 사용하면 변형·악화될 수 있다.

수두와 famciclovir

연자는 수두 치료에 고려할 수 있으나 국내 허가사항에 수두 적응증은 별도 명시되지 않았고, 성인 수두 직접 임상시험 근거는 acyclovir가 더 확립되어 대표적으로 소개했다고 답했다.

임상 연결 · 정준민 연자의 Q&A 답변 — 형태만으로 진단하지 않는다

연자 Q&A: 안과·진단 기록

정준민 연자의 Q&A 답변 — 대상포진 외래 판단

V1 영역

이마·윗눈꺼풀·코의 대상포진은 안증상 없이도 조기 의뢰한다. 각막염·포도막염은 늦게 나타날 수 있다.

더 신속한 평가

시력저하·충혈·안구통·눈부심, 코끝·코옆 수포는 신속한 평가 대상이며 시력저하·안구통이면 당일 진료를 권했다. Hutchinson 징후가 없어도 안합병증을 배제하지 않는다.

치료·기록

안과 진료를 기다리며 전신 항바이러스제를 늦추지 않는다. 전형 병변을 직접 확인했다면 임상 소견으로 진단하며 모든 환자에 바이러스검사가 필요한 것은 아니다.

임상 연결 · 정준민 연자의 Q&A 답변 — 대상포진 외래 판단

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

연자 Q&A: 통증의학과 의뢰

정준민 연자의 Q&A 답변 — 대상포진 외래 판단

조기 의뢰 조건

심한 초기 통증으로 수면·일상에 지장, 적절한 약물치료에도 조절 불충분, 약물 부작용·동반질환으로 사용·증량이 어려운 경우.

지속 통증

피부 호전 후에도 의미 있는 통증이 지속하면 의뢰한다. 고령·심한 초기 통증·광범위 발진은 통증 지속 위험요인으로 적극 추적한다.

일률적 중재보다 개별 판단

모든 환자의 초기 통증의학과 의뢰나 신경차단술이 필수는 아니다. 심한 통증이면 포진후신경통 정의의 발진 후 3개월까지 기다리지 않는다.

임상 연결 · 정준민 연자의 Q&A 답변 — 대상포진 외래 판단

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의 내용을 외래 진료의 흐름으로 연결합니다

형태·분포·약물력과 동반 증상으로 진단의 방향을 잡는다

학습의 출발점

형태·분포·약물력과 동반 증상으로 진단의 방향을 잡는다
내과 외래 발진 접근: 형태·분포·약물력에서 전신질환까지

PHONE

031-893-4560

HOURS

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
드림타워2 4층 402~404호

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

의료진 학습자료 다시 보기

광교바른내과 · 의료진 학습자료